ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ · ПАМЯТКА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Запоры у детей первого года

Питание, питьевой режим и красные флаги

Запор — это не только редкий стул. Диагноз ставят по совокупности признаков: частота, консистенция, натуживание и боль. У младенцев тактика почти всегда начинается с питания и режима.

Диагностические ориентиры

- Стул реже 3 раз в неделю, плотная консистенция, натуживание более 10 минут, болезненность.
- У детей на грудном вскармливании редкий стул может быть нормой при мягкой консистенции и хорошем самочувствии.
- Важно оценивать динамику веса, аппетит, наличие крови в стуле.

Красные флаги

- Отхождение мекония позже 48 часов после рождения.
- Вздутие живота, рвота, кровь в стуле, задержка роста.
- Отсутствие самостоятельного стула с первых недель жизни — исключать болезнь Гиршпрунга.
- Системные симптомы: гипотиреоз, целиакия, гиперкальциемия.

Питание и режим

- Достаточный объём питания и жидкости по возрасту; вода — при введении прикорма.
- Кисломолочные смеси и смеси с пребиотиками — при склонности к плотному стулу.
- Массаж живота, гимнастика, выкладывание на живот, режим дня.
- Соки и «народные» слабительные — с осторожностью и только по согласованию.

Когда пересмотреть смесь

- Если запор сочетается с кровью в стуле, экземой или плохой прибавкой — исключать АБКМ.
- Смена смеси — не чаще одного раза в 3–5 дней, с оценкой эффекта.
- При отсутствии эффекта 2–4 недели — направить к гастроэнтерологу.

Признак	Действие
Плотный стул, беспокойство, вес в норме	Коррекция питания и режима, наблюдение 2 недели
Кровь в стуле, экзема, плохая прибавка	Исключать АБКМ, элиминационная диета
Вздутие, рвота, задержка стула с рождения	Срочно исключать органическую патологию

Демонстрационный материал. Текст подлежит утверждению медицинским отделом компании перед публикацией. Не является инструкцией по применению.